

33 - Les Thymorégulateurs - Pr. BENALI

(0:06 - 0:34)

Chers étudiants, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième cours qui s'intitule les thymorégulateurs. Un certain nombre d'objectifs pédagogiques ont été fixés, et au terme de cette question, un étudiant en 5e année de médecine sera en mesure de définir un thymorégulateur, de connaître les mécanismes d'action des thymorégulateurs, cerner leurs indications, leurs contre-indications, ainsi que leurs effets secondaires.

(0:35 - 1:17)

Il sera aussi capable de maîtriser les modalités de prescription. Pour cela, j'ai établi ce plan qui est pratiquement identique à celui du cours sur les antidépresseurs. Je vais définir les thymorégulateurs, décrire certains enjeux pertinents de cette question, passer en revue les différents mécanismes d'action des thymorégulateurs, pour s'intéresser dans le troisième chapitre aux classifications des thymorégulateurs, parler des indications, des contre-indications, ainsi que des effets secondaires, et s'attarder sur les modalités de prescription des thymorégulateurs.

(1:20 - 1:48)

Un normothymique ou un thymorégulateur est un agent psychotrope, un médicament qui est capable de traiter et prévenir les symptômes maniaques et dépressifs dans les troubles bipolaires. C'est un médicament qui est destiné à réguler l'humeur et à maintenir le thymie. Trois classes importantes sont à envisager durant ce cours, les sels de lithium, les anticonvulsivants, ainsi que les antipsychotiques atypiques.

(1:51 - 2:19)

Cette question est importante étant que vous le savez, le trouble bipolaire est un trouble typique 1 à 2% de la population générale. C'est un trouble invasif qui a des comorbidités importantes, notamment les psychiques, les addictions et les troubles mentaux. Il altère considérablement la qualité de vie des personnes avec des symptômes résiduels, des troubles cognitifs majeurs, ainsi que des manifestations traumatiques, notamment cardiovasculaires.

(2:21 - 3:02)

Si l'indication et le choix du traitement sont efficaces, le suivi et l'éducation du patient impliquent tous les pratiques. Pour le deuxième chapitre des mécanismes d'action des neuromusculaires, il faut savoir que les modalités d'action des thymies régulateurs sont des systèmes nerveux qui sont analoges et chirurgiques. Ils agissent à plusieurs niveaux de la transmission nerveuse, soit par un effet direct sur les neurotransmetteurs, soit en stabilisant les membranes, soit en inhibant le système de transduction, ou par un effet anti-kindly.

(3:03 - 3:37)

En cinquième point, on s'intéressera à l'effet de ces médicaments sur certains organes. Chacun de ces mécanismes repose sur une action directe ou indirecte. Au niveau des neurotransmetteurs centraux, les thymies régulateurs augmentent par exemple le catabolisme de la sérotonine, ce qui peut être à l'origine d'une action anti-agressive, anti-dépressive et anti-suicide.

(3:37 - 4:10)

Au niveau dopamine, ils ont une action et une activité antagonistes dopaminergiques, ce qui peut être à l'origine d'une action anti-maniaque. Le lithium diminue la libération des catécholamines, il accélère leur dégradation pré-synaptique en augmentant leur captation. Il diminue la sensibilité des récepteurs post-synaptiques, ce qui explique un effet hypotenseur, une somnolence et des troubles de l'attention induits par le lithium.

(4:12 - 5:01)

Les thymies régulateurs facilitent aussi le système GABA, ce qui peut entraîner un effet anxiolytique. Cette diapo résume que le lithium facilite la neurotransmission sérotoninergique, il a une action antagoniste dopaminergique, facilite comme les autres l'activité du système GABA et diminue la libération des catécholamines. L'effet stabilisateur de membrane passe par la modification des canaux sodiques voltage dépendant, avec une activation de la pompe sodium-potassium et un blocage des canaux calciques et potassiques, avec modification de leur taux périmembrané.

(5:07 - 5:40)

Les thymies régulateurs modulent les systèmes de transduction, avec un effet sur les systèmes de second messenger, l'impeccique et l'inositol, et créent une croissance neurétique. Pour le quatrième mécanisme, il s'agit du kindling, ce qui est appelé aussi l'embrasement cellulaire. C'est ce qui est à l'origine du modèle et du concept d'épileptogènes.

(5:40 - 6:07)

L'administration répétée et intermittente d'un stimulus inférieur au seul épileptogène, dans l'épilepsie, va induire une crise épileptique généralisée, et la génération de plusieurs crises induit la génération de crises spontanées sans le moindre stimulus. C'est ce qui se passe dans le trouble bipolaire. Les épisodes thymiques répétés créent une vulnérabilité biologique, ce qui facilite les récidives.

(6:08 - 6:27)

Les antiépileptiques préviendraient le kindling au niveau du lobe limbique. Les

thymorégulateurs agissent sur un certain nombre d'organes, ce qui peut expliquer les effets secondaires. Sur le cerveau, par exemple, il y a une augmentation de la glycogénèse cérébrale.

(6:28 - 6:57)

Pour la thyroïde, les thymorégulateurs diminuent la libération des hormones thyroïdiennes avec risque d'hypothyroïde. Le système hématopoïdique peut être touché avec une augmentation du taux des globules blancs. Le cœur peut être aussi une cible avec une accélération de la conduction sinusale par déplacement du potassium intracellulaire, ce qui est à l'origine d'un risque de trouble de la conduction, de la repolarisation et de rythme cardiaque.

(6:58 - 7:44)

Au niveau rénal, l'expression par exemple du lithium est modifiée par l'insuffisance rénale ou par augmentation de la réabsorption tubulaire en cas de déshydratation, de régime dessauté ou quand le patient est sous diurétique, ce qui est à l'origine d'un risque d'augmentation des concentrations plasmatiques du lithium et bien évidemment un risque majeur d'intoxication. Le lithium provoque aussi une insensibilité à la vasopressine, ce qui diminue la concentration des urines et qui peut être à l'origine d'une néphropathie tubulo-interstitiale. Les thymorégulateurs ou normothymiques sont classés en trois rubriques, d'abord le lithium, puis les anticonvulsivants et les antipsychotiques atypiques.

(7:45 - 8:29)

On s'intéressera dans ce cours plus aux deux premiers, à savoir le lithium et les antiépileptiques, puisque les antipsychotiques atypiques seront traités dans le chapitre des neuroleptiques et antipsychotiques. Je vous ai rassemblé dans cette diapositive un certain nombre d'informations qui forment le tableau pour vous faciliter la tâche. Je voudrais dire que le lithium reste le point de référence dans les épisodes suivants.

(9:30 - 10:04)

Certainement, c'est très simple, on va le voir plus tard, par rapport à l'anticipation, il se manifeste selon la liquidité du bar de symptôme avant de l'après-midi. C'est la législation. Pour la deuxième place, les entreprises productives, qui partent en déduit de la parole indépendante, il y a évidemment les syndicats d'entreprises et d'entreprises, en particulier les syndicats de l'Université de Paris, qui sont les objectifs.

(10:41 - 11:42)

Les syndicats de l'Université de Paris, sont les syndicats de l'Université de Paris, qui partent en déduit de la parole indépendante. Les syndicats de l'Université de Paris, qui partent en déduit de la parole indépendante. Merci à tous et à bientôt.

(11:43 - 12:23)

Le troisième anticonvulsif, c'est l'anesthésie. L'anesthésie, c'est la structure astuce. Dans les épisodes maniaques avec addiction, c'est une idée prophylactique, et elle est utilisée pour prévenir le recul d'un truc de couleur 1 et de couleur 2. En termes de procédure, il y a malheureusement un certain nombre d'effets tout à l'heure.

(12:23 - 13:12)

Il va falloir s'occuper des effets. Ils ne sont pas utilisés en cas d'hypersensibilité ou de risque de glaucome angle fermé. Et bien évidemment, ils ont un certain nombre d'effets secondaires, à savoir les troubles métaboliques, certains troubles cardiovasculaires, un diabète, une crise de poids, une augmentation des transaminases et des effets extrapyramidaux.

(13:20 - 13:46)

Sur cette diapo, les effets indésirables sont résumés et les effets qui apparaissent en caractère très gras soulignés ont une grande portée significative. Si on prend par exemple le lithium, il faut s'intéresser à la polyurie, mais il faut aussi prêter attention au tremblement, au gain pondéral et à l'hypothyroïdie. Donc il va falloir retenir ces effets secondaires qui sont très importants, notamment dans le cadre du suivi d'un patient sous thymorégulateur.

(14:06 - 14:44)

Pour les modalités de prescription des thymorégulateurs, j'avais évoqué tout à l'heure que l'instauration d'un traitement thymorégulateur se fait en plusieurs étapes. Il va falloir faire un bilan préthérapeutique et suivre un certain nombre de consignes d'introduction et d'adaptation de posologie. Le premier point que l'on développe c'est qu'il y a un bilan préthérapeutique à la fois clinique et paraclinique qui reste indispensable.

(14:45 - 15:41)

Il est réalisé avant l'initiation du traitement, avec une anamnèse à la recherche des contre-indications, un examen clinique complet, notamment neurologique, des prises de constantes, avec une mesure de la moitié et des examens complémentaires dont un bilan biologique. Un certain nombre d'examens complémentaires sont à demander, notamment une NFS, des plaquettes, un ionogramme sanguin, un test H ultrasensible, un bilan hépatique pour les anticonvulsivants, un test de grossesse chez la femme en âge de procréer, et réalisé avant l'instauration du lithium à une ECG et un bilan urinaire. Ce tableau rappelle les contre-indications.

(15:41 - 15:58)

Quand on fait un examen clinique et un examen paraclinique, et quand on veut prescrire du lithium, il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas une insuffisance rénale ou une dépression

hyposodique. Il ne faut pas qu'il y ait une coronaropathie ou une insuffisance cardiaque. Il ne faut pas que la femme a l'aide ou qu'elle est enceinte au premier trimestre.

(15:59 - 16:35)

Cela est valable aussi pour la carbamazépine, pour l'acide valproïque. Un certain nombre de pathologies sont à rechercher cliniquement et biologiquement. Je les ai mis sous forme de tableau pour que vous vous rappeliez parfaitement bien qu'il faut chercher au niveau néphrologique, au niveau cardiaque, prêter attention à toute femme en âge de procréer, rechercher les antécédents et faire attention aux précautions d'emploi, notamment les insuffisances léptocellulaires, rénales, cardiaques ou chez la personne âgée.

(17:20 - 20:32)

Les cas de l'insuffisance cardiaque sont à atteindre entre 0,5 et 0,8. On va donc augmenter. Et l'état cutané du patient, la surveillance biologique se fait pratiquement tous les deux Une fois par an, avec obligatoirement une créatinine et un bilan thérapeutique Il faut faire attention aux interactions médicamenteuses comme les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les neuroleptiques, l'inhibiteur d'angines de conversion et l'antagoniste d'angiotensines 2 Merci.

(21:18 - 22:46)

Merci à tous. Une fois par semaine jusqu'à stabilisation de la lithémie par exemple, puis une fois par mois tous les trois mois, puis une fois tous les deux à trois mois. Il s'agit pour le lithium de la lithémie intra-érythrocytaire, une notion qui est très importante, une fois par an, pour les anticonvulsivants, le bilan biologique de la lithémie intra-érythrocytaire.

(22:46 - 23:11)

sur les différents thérapeutiques qui existent, sur la maladie, sur les rythmes de vie, et bien évidemment un certain nombre de règles à apprendre aux patients, surtout les patients qui sont sous lithium. Tout patient sous lithium doit prévenir son médecin qu'il est sous thymorégulateur. Les patients sous lithium doivent éviter les associations avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec les cyclines, avec les diurétiques, avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion.

(23:12 - 23:56)

Il faut que les patients s'hydratent convenablement, qu'ils n'ont pas de régime sans sel, et si jamais ils oublient une dose, qu'ils ne doublent pas la dose plus tard. Si jamais il y a de la soif, des nausées, une diarrhée, une fatigue et un tremblement, il faut envisager une consultation chez le médecin. Quant à la durée du traitement et son efficacité, en principe il s'agit d'un traitement préventif, donc c'est un traitement qui est considéré à vie, mais il va falloir aussi respecter le souhait et la volonté du patient.

(23:57 - 24:25)

Certaines personnes veulent arrêter, après un certain nombre d'années de thymie, le traitement. Le but d'un arrêt progressif étant de prévenir les rechutes et surtout de prévenir les convulsions chez les patients qui étaient sous anticonvulsives. Vous demanderez bien sûr l'avis d'un psychiatre.

(24:26 - 25:07)

Quand le tableau est sévère, soit par son intensité, soit par l'existence d'un risque suicidaire ou un retentissement des symptômes, si vous jugez que le traitement est insuffisamment efficace et ou mal toléré, quand il y a des événements intercurrents qui surviennent, ou quand vous voyez que vous êtes dépassé par la situation. Au terme de cette question et en guise de conclusion, ces différentes classes de normes thymiques sont commercialisées au Maroc. Il s'agit de médicaments capables, dans quelques semaines, d'améliorer l'état thymique du malade.

(25:08 - 25:22)

Une psychothérapie et une psychoéducation doivent être systématiquement associées. Il importe d'expliquer aux patients les modalités de prise de son médicament et être attentif au vécu de sa maladie. L'écoute est primordiale dans ce contexte.

(25:23 - 25:27)

Je vous souhaite une bonne écoute de ce cours sonorisé et à très bientôt.